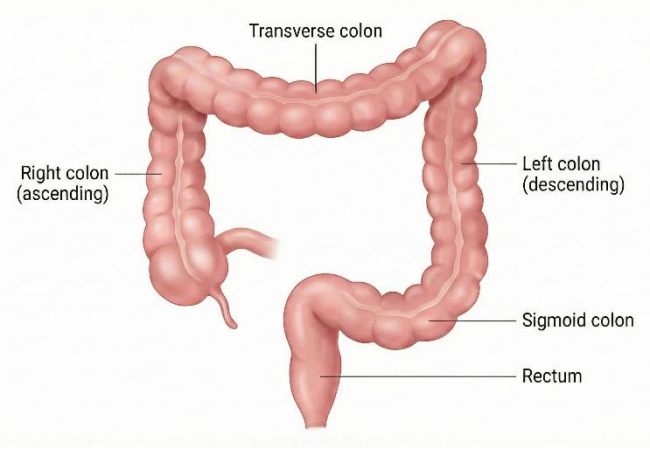
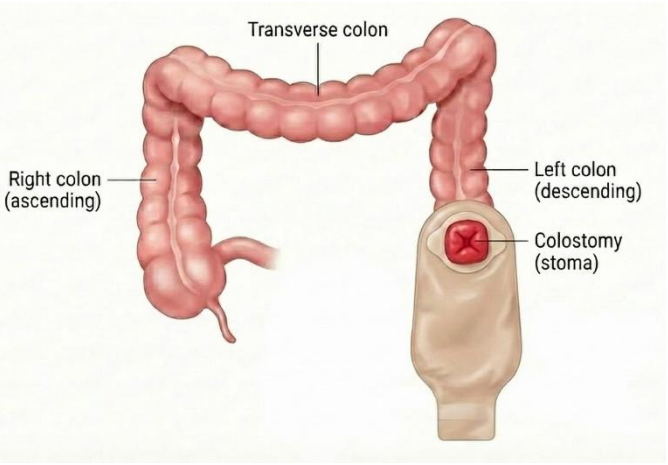
AMPUTACIÓN ABDOMINOPERINEAL

Mª Elisa de Castro Peraza, Judith Reguera Cabrera, María Pérez López, Mª Elba Palomares Ramos, Juan José Gutiérrez Adrián, Nieves Lorenzo Rocha

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS

Técnica quirúrgica para el tratamiento del Ca de recto bajo, especialmente cuando se afecta el esfínter anal, con el objetivo de conseguir una erradicación completa de la enfermedad y disminuir la posibilidad de recidiva. Mediante esta cirugía, se reseca el sigma, recto, ano y parte del periné, así como la grasa (meso) que lo circunda. El extremo de colon sano se aboca a la pared abdominal en forma de colostomía definitiva.





POSICIÓN QUIRÚRGICA DEL PACIENTE

La cirugía se realiza en dos tiempos bien definidos. Por un lado, está la parte intracavitaria donde se prepara el intestino para la resección y la posterior colostomía. Por otra parte, el tiempo perineal donde se extrae la pieza y se cierra el orificio anal. Esto da lugar a dos posiciones distintas según los tiempos de la cirugía:

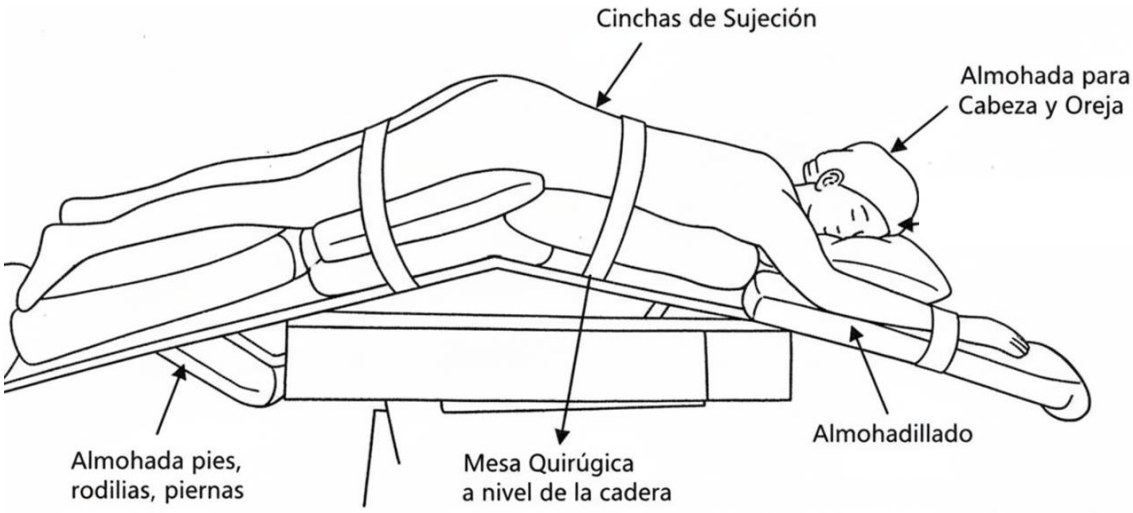
Parte abdominal

- Decúbito supino.
- Brazos pegados.
- Perneras bajas.
    - Si el paciente es obeso y la sujeción de las perneras es deficitaria, se reforzará con venda crepé.
- Almohada de silicona para la cabeza.

Para la **parte perineal**, se suele colocar al paciente en decúbito prono, concretamente en posición de Kraske o navaja sevillana. En ocasiones se puede realizar también en posición de litotomía (con perneras altas).

En el caso de poner al paciente en Kraske:

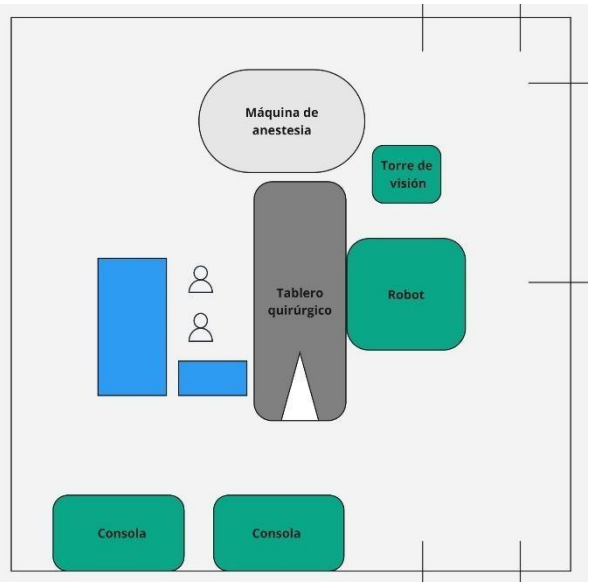
- Decúbito prono.
- Cadera sobre el flex del tablero para flexionar.
- Brazos flexionados hacia la cabeza con apoyabrazos.
- Piernas juntas.
- Especial protección en zonas sensibles como el pecho (mujeres) o genitales masculinos.
- Protección en zonas de apoyo (codos, caderas, rodillas y dedos de los pies) y liberación de articulaciones (cuello, hombros, rodillas y tobillos).
- Dos tiras de esparadrapo traccionan del glúteo hacia fuera para exponer mejor el campo.



Si se opta por la posición de litotomía, es importante comprobar el apoyo adecuado de los miembros inferiores a las perneras.

POSICIÓN DEL EQUIPO QUIRÚRGICO Y CONFIGURACIÓN DEL DA VINCI

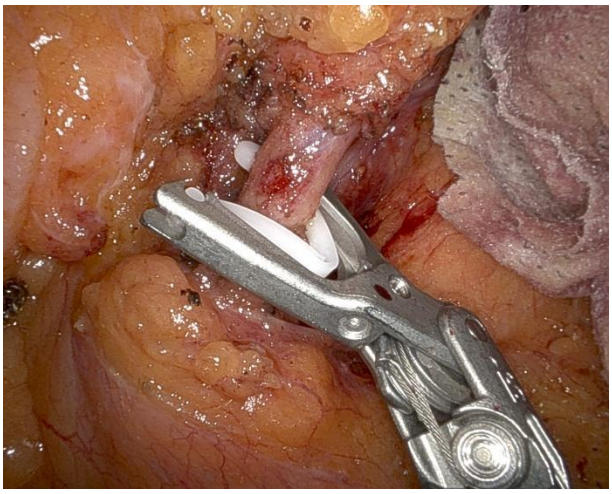
- Anatomía: abdominal inferior.
- Lado: izquierdo.
  - Brazo 1: Tip-up
  - Brazo 2: Bipolar fenestrada
  - Brazo 3: Óptica de 30º
  - Brazo 4: Tijera / Vessel-sealer / Hemolock
- Tablero quirúrgico:
  - Trendelemburg 25º
  - Side derecho 10-12º
  - Perneras bajas -10º



TÉCNICA QUIRÚRGICA

- Previa preparación del campo estéril, puede ser necesario realizar un lavado rectal.
- Colocación de campo y trócares.
- Revisión de la cavidad y resección de adherencias. La revisión puede ser laparoscópica, por lo que conviene tener dos grasper montados desde el inicio.
- Para una mejor separación de las estructuras y secado durante la cirugía, se usará un QuirPad (cilindro grueso y alargado de dos gasas abiertas longitudinalmente y enrolladas, fijadas varios puntos con seda)
- Se realiza la exploración de la cavidad abdominal para estadiaje de la enfermedad, se movilizan las asas intestinales y se visualiza la tumoración.
- Se localiza el uréter izquierdo, rechazándolo hacia el retroperitoneo para asegurar su integridad durante la cirugía.

- Se localizan los vasos mesentéricos inferiores y, traccionando de ellos hacia la pared abdominal, se abre el peritoneo alrededor del pedículo vascular y se disecan los vasos.



- Se seccionan los vasos con hem-o-lok de DV.

- Se libera el colon descendente del retroperitoneo y del parietocólico izquierdo, así como el ángulo esplénico, para conseguir la suficiente movilización del colon que permita hacer la colostomía sin tensión.
- Se inicia la disección del mesorecto en sentido anal. Si la paciente es una mujer puede ser necesario unir el útero y los anejos a la pared abdominal con un punto suelto. Esta disección se progresa lo más distal posible.
- Una vez liberado todo el colon y recto, se corta el colon por encima del tumor con márgenes suficientes de seguridad con endograpadora de 60 azul, verde o negra dependiendo del grosor del tejido.
- Finalizado el tiempo abdominal, con el paciente en perneras o en decúbito prono según preferencias del equipo quirúrgico, se termina de disecar el extremo final del recto-ano por vía perianal.
- Si se realiza en posición de litotomía, los cirujanos se dispondrán entre las piernas. Si la posición elegida es la de navaja sevillana, hará falta un separador perineal tipo Lone Star. Con el bisturí eléctrico o el Ligasure punta maryland corto se diseca el complejo esfinteriano y se profundiza por fuera de la porción subcutánea del esfínter anal externo, alejándose de la grasa glútea.
- Se secciona la fascia presacra, lo que permite el acceso a la cavidad pélvica conectando con la disección realizada en el tiempo abdominal.
- Se seccionan los músculos elevadores del ano y se extrae con cuidado el recto por el periné desde la cavidad pelviana.

- Esto permite exponer el plano entre la vagina o las vesículas seminales y el recto que debe ser diseccionado para evitar la lesión de dichas estructuras, y se termina de resecar la pieza.
- Se entrega la pieza y se cierra la herida perineal.

¡IMPORTANTE!

El material utilizado en esta parte de la cirugía se considera sucio o contaminado, por lo que debe desecharse o apartarse en cuanto se termine.

El resto de la cirugía debe hacerse con material limpio que no haya estado en contacto ni expuesto a la zona sucia.



- Cambio de batas y guantes para el equipo quirúrgico.
- Se vuelve al tiempo laparoscópico para comprobar el asa que se quedará como colostomía y se deja sujeta con el clinch. Se comprueba la vascularización mediante el verde de indocianina. Una posible dilución es diluir 25 mg en 10cc de agua bidestilada. Se suelen inyectar 5 ml de esa disolución, es decir, 12.5 mg. Es conveniente arrastrar con un bolo de suero fisiológico la indocianina e inyectarle en una vía lo más proximal posible. Hay que tener cuidado con la dosificación máxima en pacientes especialmente susceptibles: mala función hepática, cardiópatas etc. Respetando la recomendación de farmacia, no se deben administrar cantidades mayores a 0.3 mg/kg en pacientes cardiópatas y 0.5mg/kg en patologías hepáticas
- Comprobación de hemostasia, colocación de drenaje y cierre de heridas quirúrgicas con oclusión temporal para evitar contaminación de las heridas limpias.
- Se realiza y fija la estoma con vicryl 3-0 (se necesitarán cuatro suturas) y se comprueba permeabilidad con un poco de lubricante.
- Colocación de la placa y la bolsa de la estoma para dejarla definitivamente aislada.
- Cura definitiva de heridas quirúrgicas limpias.

NOTAS

- Puede ser necesario colocar una malla en la pelvis. En este caso se selecciona una que pueda estar en contacto con las asas intestinales, tipo BioA o similar.
- Pueden ser precisos dos drenajes, uno intracavitario con vacío de baja presión o por gravedad, y el otro en el periné con vacío tipo redón.

BIBILIOGRAFÍA

1. Amputación Abdominoperineal con Asistencia Robótica Abdominoperineal amputation with Robotic Assistance O. García Villar, A. Vivas López, E. Rubio González, C. Nevado García, P. Peláez Torres, M. Labalde Martínez, D. Alias Jiménez, J. García Borda, E. Ferrero Herrero DOI: https://www.doi.org/10.14679/3513